

NOTA DE EVOLUCIÓN DE URGENCIAS



HE-DIRMED-SINPRO-PLT-87/01

Fecha de Ingreso 18 / 08 / 2026 Hora: 14 : 31
DD MM AAAA

Nombre del Paciente: **COMODIN COMODIN COMODIN** Fecha de Nac.: **06 Oct 1994**
Expediente: **PT-5704 Cama: Urgencias Edad: 31 años años** Sexo: **M [X] F []** Grupo/RH: **O+**
Alergias: **PENICILINA, SULFAS**
Diagnóstico(s): **DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN FOSA ILIACA DERECHA. SOSPECHA DE APENDICITIS AGUDA. SE SOLICITAN ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE PARA CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA.**
Destino: **PISO / QUIROFANO** Fecha Egreso: / / Hora: :
Fecha de Nota: **18/08/2026 Hora: 14:31** Turno: **Matutino [X] Vespertino [] Nocturno []**

Evolución y observaciones

Signos vitales TA: 130/85 FC: 92 FR: 20 SATO2: 96% PESO: 78.5 kg TALLA: --

(S) Subjetivo:

Paciente masculino de 35 años que acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal tipo cólico de 12 horas de evolución, localizado inicialmente en epigastrio y que posteriormente migró a fosa ilíaca derecha. Refiere náusea, un episodio de vómito de contenido gástrico, hiporexia desde el inicio del cuadro y sensación de distensión abdominal. Niega fiebre cuantificada en casa, niega diarrea, niega síntomas urinarios. Antecedentes: Sin cirugías previas. Alérgico a Penicilina y Sulfas. Sin enfermedades crónico-degenerativas conocidas.

(O) Objetivo:

EXPLORACIÓN FÍSICA:

- Paciente consciente, orientado, álgico, en posición antiálgica (decúbito lateral derecho con flexión de miembros pélvicos).
- Signos vitales: TA 130/85 mmHg, FC 92 lpm, FR 20 rpm, Temp 38.2°C, SatO2 96%.
- Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha. McBurney positivo. Rebote positivo. Rovsing positivo. Psoas positivo.
- Peristalsis disminuida.
- Sin datos de irritación peritoneal generalizada.
- Extremidades íntegras, llenado capilar 2 segundos.

(A) Análisis:

ANÁLISIS / VALORACIÓN:

Se trata de paciente masculino con cuadro clínico sugestivo de apendicitis aguda con base en:

1. Migración del dolor de epigastrio a FID (secuencia cronológica de Murphy).
2. Signos apendiculares positivos (McBurney, Rovsing, Psoas).
3. Fiebre y taquicardia como datos de respuesta inflamatoria.
4. Escala de Alvarado: 8 puntos (alta probabilidad).

Se solicitan: BH completa, QS, EGO, PCR, USG abdominal focalizado en FID.

Se mantiene en ayuno y se inicia solución cristaloide.

(P) Plan (laboratorios solicitados y tratamientos a establecer):

PLAN TERAPÉUTICO:

1. Ayuno estricto.
2. Solución Hartmann 1000ml IV para 8 hrs.
3. Ketorolaco 30mg IV c/8hrs (analgesia - NO AINES por alergia a sulfas confirmada, ketorolaco es seguro).
4. Ondansetrón 4mg IV c/8hrs PRN (antiemético).
5. Omeprazol 40mg IV c/24hrs (protección gástrica).
6. Solicitar: BH, QS 3, EGO, PCR cuantitativa, TP, TTP, Grupo y Rh.
7. Solicitar USG abdominal urgente focalizado en FID.
8. Interconsulta a Cirugía General si se confirma diagnóstico.
9. Vigilancia estrecha de signos vitales cada 2 horas.
10. Revalorar con resultados de laboratorio y gabinete.

DR. ALEJANDRO MENDOZA RIVERA

Céd. Prof. 12345678

Nombre Completo , Firma y Cédulas del Médico

Nombre Completo y Firma del MIP

FUNDACIÓN MARÍA ANA MIER DE ESCANDÓN, I.A.P.